



Informe del Registro Uruguayo de Glomerulopatías Julio 2026. Datos del año 2024 y preliminares de 2025

Introducción:

La incidencia de las glomerulopatías (GP) tiene amplias variaciones probablemente vinculadas a variaciones de la incidencia real de las diferentes patologías, aunque también dependientes del acceso a la biopsia renal, de las diferentes técnicas diagnósticas disponibles, de las prácticas nefrológicas, de las variaciones socioculturales y económicas.

El Programa de Prevención y Tratamiento de las Glomerulopatías (PPTG) tiene entre sus objetivos la descripción de la incidencia de las diversas glomerulopatías y su forma de presentación, para poder comunicar dichas variaciones a la comunidad nefrológica, los prestadores de salud y las autoridades. Por este motivo, desde 2010 se realiza un informe anual con los datos del Registro Uruguayo de Glomerulopatías. Estos informes están disponibles en:

<https://www.nefrologia.hc.edu.uy/index.php/prevencion-glomerulopatias>

Nuestro país tiene como características la facilidad de desplazamiento en el territorio, la accesibilidad a los servicios de salud, la existencia de un reducido número de nefropatólogos, lo que nos permite conocer la totalidad de las biopsias renales realizadas en el país en un período de tiempo.

Objetivo:

En esta comunicación se continúa la serie de informes del Registro Uruguayo de Glomerulopatías (RUG) iniciada en el 2010 e incluyendo los datos de 2008 en adelante, referentes a la primera biopsia de riñón nativo. En este caso, se actualiza la información referente al año 2024 y se brindan cifras preliminares de 2025.

Metodología:

Se recolectaron los datos de punciones biópsicas renales (PBR) de los laboratorios de Anatomía Patológica que concentran las biopsias renales no oncológicas. Los datos clínicos fueron solicitados a los nefrólogos tratantes y/o relevados por el patólogo al momento de la biopsia. La información recabada por esta vía referente a 2025 puede ser aún imprecisa, dado el breve lapso transcurrido desde la realización de la biopsia hasta la elaboración del informe. Completar los datos clínicos de cada paciente es un proceso largo y laborioso que involucra la colaboración honoraria y desinteresada de los nefrólogos que deben dedicar parte de su tiempo a completar los datos solicitados.

Se calculó la frecuencia de PBR y glomerulopatías por millón de población y en particular para mayores de 14 años. Para el cálculo de tasas se estimó la población general mediante extrapolación lineal a partir de los datos censales de 2011 y 2023. (Fuente: INE) De esta forma, la población se estimó en 3.517.212 para 2024 y 3.534.974 para 2025. Los mayores de 14 años se estimaron en 2.876.802 para 2024 y 2.900.332 para 2025.

Los diagnósticos considerados fueron la lesión glomerular mínima (LGM) (denominada actualmente Enfermedad por cambios mínimos), la esclerohialinosis focal y segmentaria (EHFS), la glomerulopatía membranosa (GM), la glomerulonefritis membrano-proliferativa (GNMP), la nefropatía a IgA (NIgA), lupus, vasculitis, mieloma, amiloidosis, diabetes y microangiopatía trombótica. Los restantes diagnósticos se agruparon en las categorías "otros".

Algunas GP se agruparon para su análisis: las vasculitis incluyen: vasculitis pauciinmune (ANCA negativa, MPO, PR3 y sin clasificar, glomerulonefritis proliferativa intra y extracapilar, la glomerulopatía por crioglobulinas, la enfermedad por anticuerpos anti membrana basal glomerular y la enfermedad de Goodpasture. Para este análisis se agruparon las formas de enfermedad por IgA limitada al riñón y vasculitis IgA (antes denominada enfermedad de Schönlein Henoch).

Se analizó sexo, edad y forma de presentación de la enfermedad. La forma de presentación procede del reporte de los nefrólogos y/o la información recabada por el nefropatólogo al momento de la biopsia, codificadas según las definiciones del programa de PPTG, de acuerdo a la información con la que cuentan los patólogos al momento de la biopsia renal. En un 67.4% de los casos se carece de esta información para el período 2024-2025.

Resultados

En el período 2024-2025 se realizaron 610 primeras biopsias en riñones nativos (291 en 2024, 319 en 2025) lo que corresponde a tasas de primera biopsia de 82,7 por millón de población (pmp) en 2024 y 90,2 pmp en 2025. La figura 1 muestra la evolución de la cantidad de PBR en el período 2012-2025. Se puede observar un marcado descenso en la cantidad de procedimientos en los años 2020 y 2021 en relación a la pandemia de COVID-19 y la posterior recuperación a partir del año 2022 con un aumento particular en 2025.

Quinientos cincuenta y cuatro estudios correspondieron a GP (268 en 2024 y 286 en 2025), 53 a alteraciones vasculares o túbulo intersticiales y 3 fueron biopsias que no correspondieron a riñón y no se repitieron en el período. De acuerdo con estos datos, la tasa de incidencia de GP fue de 76,2 pmp en 2024 y 80,9 pmp en 2025. La edad de los pacientes cuyas biopsias correspondieron a GP fue de 1 a 89 años, con una media ($\pm$ desvío estándar (DE)) de 43,6 años ($\pm 20,3$) y mediana de 45 años (datos de 545 pacientes). La distribución de edades se muestra en la figura 2.

Figura 1: Evolución del número de punciones biópsicas renales diagnósticas en el período 2012-2025

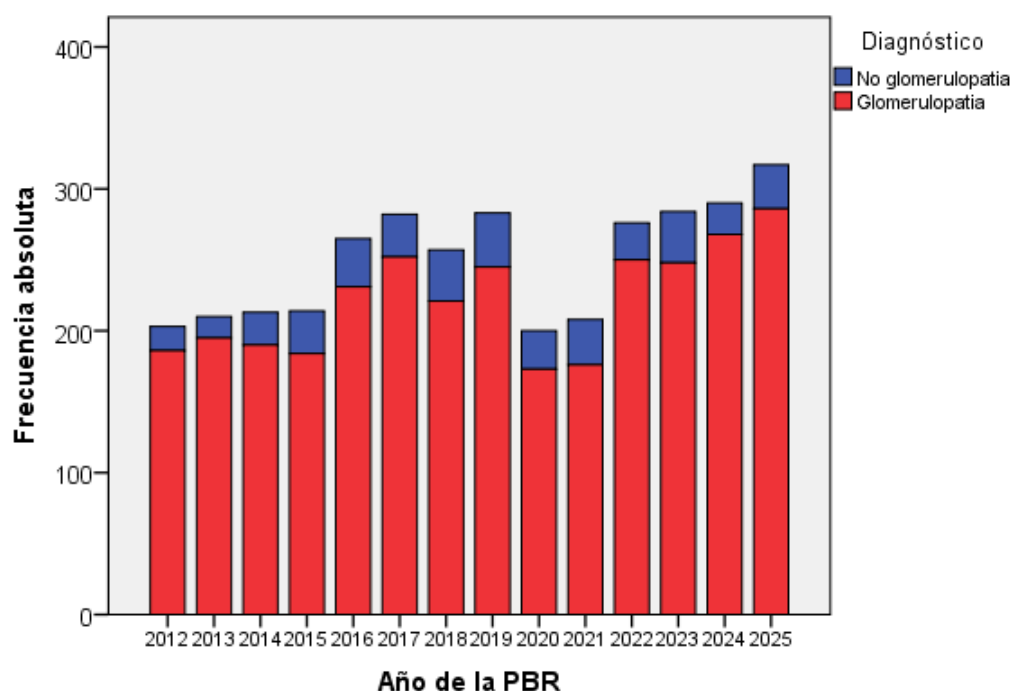
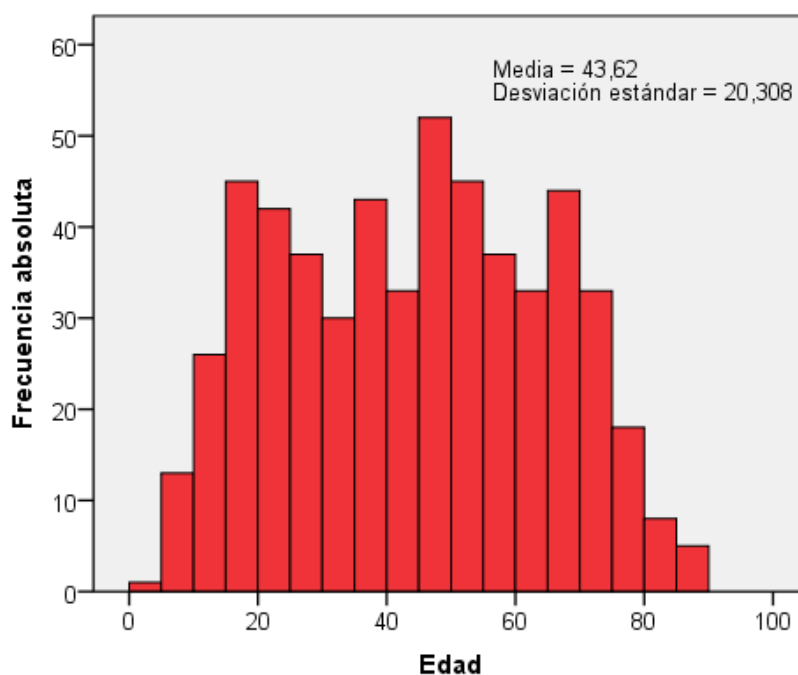


Figura 2. Distribución de edades de los pacientes con glomerulopatía en riñón nativo biopsiados por primera vez en 2024-2025



Glomerulopatías en pacientes mayores de 14 años

Del total de GP registradas en el bienio 2024-2025, 514 correspondían a mayores de 14 años (243 en 2024 y 271 en 2025). La incidencia anual en mayores de 14 años fue 84,4 pmp en 2024 y 93,4 pmp en 2025. El 50,4% de los pacientes eran hombres. La

media ($\pm$ DE) de edad entre los mayores de 14 años fue 46,3 años ($\pm$ 18,7). La tabla 1 muestra la distribución por grupos etarios de los pacientes, discriminados por año de realización del estudio (sin dato de edad de 9 pacientes).

Tabla 1. Edad al momento de la biopsia en el período 2024-2025 (Mayores de 14 años)

Edad	2024		2025		Total	
	n	%	n	%	n	%
15-24	42	17,3	45	17,2	87	17,2
25-34	28	11,5	39	14,9	67	13,3
35-44	35	14,4	41	15,6	76	15,1
45-54	48	19,8	49	18,7	97	19,2
55-64	38	15,6	32	12,2	70	13,9
65-74	39	16,1	38	14,5	77	15,2
75-84	10	4,1	16	6,1	26	5,1
85 y más	3	1,2	2	0,8	5	1,0
Total	243	100,0	262	100,0	505	100,0

Los diagnósticos más frecuentes en las biopsias correspondientes a glomerulopatías fueron la EHFS (22,4%) y la nefropatía IgA (18,7%) como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2: Diagnóstico de las glomerulopatías biopsiadas en mayores de 14 años. Período 2024-2025

Diagnóstico	Frec. absoluta	Porcentaje
LGM	30	5,8
EHFS	115	22,4
GM	44	8,6
GNMP	12	2,3
N IgA	95	18,5
Lupus	56	10,9
Diabetes	21	4,1
Vasculitis	51	9,9
Amiloidosis	13	2,6
MAT	9	1,8
Otras	21	4,1
Inclasificable	47	9,1
Total	514	100.0

LGM: Lesión glomerular mínima, EHFS: Esclerohialinosis focal y segmentaria, GM glomerulopatía membranosa, GNMP: Glomerulonefritis membrano proliferativa, N.IgA: Nefropatía IgA (incluye Enfermedad de Schönlein-Henoch), MAT Microangiopatía trombótica

Se obtuvo información de la forma clínica de inicio en el 32% de los casos. De ellos, el 39% se presentó como síndrome nefrótico, 26,8% alteraciones urinarias asintomáticas, 9,8% insuficiencia renal crónica, 9,1% insuficiencia renal rápidamente progresiva.

La tabla 3 muestra la evolución de la tasa de biopsia de las distintas glomerulopatías por bienio, desde 2008 a 2025.

Tabla 3. Evolución de las tasas de incidencia de las distintas glomerulopatías.2008-2024 (por millón de población mayor a 14 años)

	2008-2009		2010-2012		2013-2015		2016-2017		2018-2019		2020-2021		2022-2023		2024-2025	
Diagnóstico	n	TI	n	TI	n	TI	n	TI	n	TI	n	TI	n	TI	n	TI
LGM	18	3,4	40	5,2	28	3,6	27	5,1	18	3,4	25	4,6	30	5,5	30	5,2
EHFS	22	4,2	47	6,1	68	8,7	81	15,3	72	13,4	67	12,3	77	14,0	115	19,9
GM	33	6,3	61	7,9	46	5,9	50	9,4	50	9,3	31	5,7	32	5,8	44	7,6
GNMP	2	0,4	17	2,2	18	2,3	15	2,8	25	4,7	15	2,8	20	3,6	12	2,1
N IgA	66	12,6	100	13,0	87	11,1	62	11,7	71	13,2	46	8,5	81	14,8	95	16,4
Lupus	23	4,4	50	6,5	63	8,0	51	9,6	50	9,3	45	8,3	54	9,8	56	9,7
Vasculitis.	33	6,3	33	4,3	48	6,1	62	11,7	28	5,2	34	6,3	44	8,0	51	8,8
Amiloidosis	13	2,5	8	1,0	18	2,3	11	2,1	8	1,5	10	1,8	19	3,5	13	2,3
Biopsia inlcasificable	30	5,7	44	5,7	52	6,6	44	8,3	32	6,0	22	4,1	30	5,5	47	8,1

TI: Tasa de incidencia por millón de población, LGM: Lesión glomerular mínima, EHFS: Glomeruloesclerosis focal y segmentaria, GM glomerulopatía membranosa, GNMP: Glomerulonefritis membrano proliferativa, N.IgA: Nefropatía a IgA (incluye Enfermedad de Schönlein-Henoch)

Glomerulopatías en niños

En este período se realizaron 41 biopsias de riñón nativo en niños, 40 de las cuales eran glomerulopatías. Los diagnósticos más frecuentes fueron: nefropatía IgA (n=14), y LGM (n=6) y EHFS (n=6).

Conclusiones:

El RUG continúa la recolección de datos gracias al valioso aporte de los anatomopatólogos y nefrólogos que dedican parte de su tiempo a enviar la información necesaria. No obstante, para mejorar la calidad de los datos e incluir información clínica relevante de los pacientes en este resumen, resulta fundamental modificar el sistema actual de captación de datos clínicos. En este sentido, se ha avanzado en el diseño de una base de datos en la plataforma REDCap que brindará la posibilidad a los nefrólogos que aportan datos, de acceder a sus datos y a un resumen actualizado de la historia clínica del paciente cuando sea necesario.